

NS

ALEXANDRE MAGNO CILI

IDADE: PESO: 126 ALTURA: 1,89 PROFISSÃO:
 SINTOMAS: Ronco / cansaço / sonolência / memória recente ruim
 QUEIXAS: esquecimento
 MEDICAMENTOS: Lixiana / Plavix / Acetaminofeno

MÉDICO: Dr.º Flávia Passarelli / Fábio Batista / Dr.º Eduardo
 EXERCÍCIO FÍSICO: 3x - musculação

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 19:30

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6h

COCHILLO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: normal BANHEIRO: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: 0,5

MALLAMPATI:

IAH: 35,8 e/h SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (S) NASAL (X) AMIGDALECTOMIA

Desvio de septo.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA arritmia

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

Paralisia facial (D) / Dor no dente / fez cardioversão

03/10/23 - Titulação.

10/10/23 - Ponto: 5 - 12 cmH₂O

P: 7,4 cmH₂O Pw: 95% - 9,8 cmH₂O

IAH: 41 e/h (C: 3,4 e/h)

m. de uso: 12l/min

fuga 7h20 min.

* Aparelho desligando

↳ hoco

P 5 - 10 cmH₂O

16/10
23

P: 9,9 cmH₂O

IAH: 2,8

m. de uso: 20,2

Aparelho desligando

achado que precisa de
troca mais - fua

06/11
23

P: 9,9 cmH₂O

IAH: 1,7

m. de uso: 5h30

fua

28/11
23

P: 8,8 cmH₂O

IAH: 2,4 e/h

m. de uso: 5h40'

Bem adaptada

19/12
23

P: 8,8 cmH₂O

m. de uso: 5h49'

IAH: 2,2

Bem adaptado fua
notas que in utiliz-
zou p/ conta de
trabalho fua

19/01 P=8,8
24 IAH=1,7
m. de uso: 1,2

Percentagem

Ana Cláudia

22/03 P=8,8 cmH₂O
24 IAH=1,5
m. de uso: 6h 39'
fluxo: 6,6 l/min

Bem adaptado pois
tem dias que não
utiliza pois viaja a
trabalho.

Natasha

24/05/24 - P=8,8 cmH₂O
IAH=1,5 el/h
m. de uso: 6h 29m
fluxo P95: 16,8 l/min
Pilata está sem
exercícios físicos há ± 1 mês

Bem adaptado
Orienta higienizar
melhor a máscara

Natasha

26/07/24 P=8,8 cmH₂O
IAH=0,8 el/h
m de uso: 1h 30'
fluxo P95: 0,6 l/min

Pilata problemas no trabalho
por isso a dificuldade de
utilizar
Oriento a usar por mais
tempo durante a noite

Natasha

03/10/24 P=8,8 cmH₂O
IAH=2,1 el/h
m de uso: 6h 54'
fluxo: 2,8 l/min

Bem adaptado
Relata estar conseguindo
utilizar melhor o equipamento

Natasha

24/05/25 P=8,8 cmH₂O
IAH=4,2 el/h
m de uso: 6h 20
fluxo: 1,4 l/min

Estava el tamanho de
bico errado, usando ⑤
Troco p/ bico ④

Natasha

14/04/25 P=8,8 cmH₂O
IAH=3,7 el/h (Ac: 2,3)
m uso: 7h 00'
fluxo: 2,1 l/min

parece atitudes finais / stress no trabalho
relata não estar dormindo bem

Nome: ALEXANDRE MAGNO CILI

Data de Nascimento: 7-5-1971

IMC: 35,27

Sexo: Feminino

Data do exame: 13-08-2023

Peso: 126 kg

Altura: 1,89 m

Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO

PASSARELI PRADO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 13-08-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 593,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 167,0 e 85,5 minutos. O tempo total de sono foi de 412,0 min, eficiência de 69,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,2%; estágio N2: 53,3%; estágio N3: 19,8%; sono REM: 25,7%. O índice de despertares foi de 18,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 35,8/hora, sendo 93 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 153 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 77%, permanecendo 12,3% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 41 - 71 bpm e NREM de 42 - 67 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (05), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM aumentada e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco durante o sono.

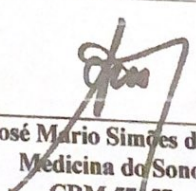
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157